

14 - 03- Les addictions aux produits - Pr. Manoudi

(0:00 - 0:56)

Alors, aujourd'hui, on va traiter les addictions, donc on va traiter les addictions produits. Parce que, comme vous savez, il y a les addictions comportementales et les addictions produits. Les deux ont des conséquences négatives sur la santé psychique, sur la santé, sur l'authenticité sur la société, sur le plan professionnel, le plan familial.

Mais les addictions produits ont beaucoup plus un retentissement plus grave sur la santé psychique, sur le fonctionnement personnel, familial et social, et aussi sur la santé physique. Donc, c'est pour ça qu'on va consacrer les heures qu'on a consacrées pour les addictions uniquement aux addictions aux produits. Donc, à la fin de ce cours, vous devez être capable de définir, connaître une addiction.

(0:57 - 1:30)

Les différents stades de consommation, ça vous permettra d'intervenir de façon préventive. Les critères de dépendance, donc pour sélectionner les gens qui sont dans la dépendance, qui ont une prise en charge beaucoup plus spécifique. Différencier entre addiction physique et psychique pour pouvoir expliquer aux patients, soit qu'il est encore dans la phase critique, il a besoin de soutien, soit qu'il a dépassé la phase critique, il suffit juste qu'il patiente un petit peu pour arriver à l'abstinence.

(1:31 - 1:52)

Les facteurs de vulnérabilité, ça c'est surtout l'intérêt de la prévention. Les facteurs de protection pour sensibiliser les gens à ce qu'ils ont des ressources qui vont les aider à s'abstenir. Et connaître surtout l'action des drogues sur le cerveau, ça c'est très important parce que c'est quelque chose que le patient va vous demander.

(1:53 - 2:22)

Que ce soit des patients d'un niveau intellectuel élevé ou pas, ils vont vous demander de leur expliquer de façon biologique comment ça marche. Et si vous leur expliquez ça, ça les aide aussi à comprendre pourquoi ils sont addicts et ça les aide aussi à être motivés pour l'abstinence. Et bien sûr, connaître l'effet psychique et physique parce que vous aurez à les donner aux patients si, et j'insiste, s'ils le demandent.

(2:23 - 2:48)

Et bien sûr, les grandes lignes de prise en charge d'un patient addict, ça relève du spécialiste. Mais en tant que médecin généraliste, en tant que médecin spécialiste, vous allez être confronté à des patients qui ont des pathologies X ou Y et qui consomment. La majorité, ça va être des

consommations courantes, des consommations fréquentes comme par exemple le tabac.

(2:48 - 3:06)

Donc vous avez à connaître la moindre des choses dans la prise en charge qui est la psychoéducation. Donc ça, c'est important. Donc là, vous avez, je pense, deviné le chaton qui a trouvé la boule de cannabis et qui a consommé la boule de cannabis.

(3:06 - 3:16)

Donc vous le voyez comment elle est. C'est vrai, ça, on le voit. Vous vous rappelez quand je vous ai dit sur l'aspect physique des patients qui ont des troubles bipolaires.

(3:16 - 3:41)

Ce sont des patients qui sont excités, jovials, euphoriques, hyperactifs et dans leurs yeux, on voit cette brillance. Là, vous voyez comment ça brille au niveau des yeux du chaton parce que les drogues, toutes les drogues, elles donnent au début. Donc des fois, de façon rapide, de façon brutale, elles vont donner ce qu'on appelle un accès psychotique aiguë post-toxique d'allure maniaque.

(3:42 - 3:59)

Elles vont donner un tableau maniaque. Donc si vous ne posez pas la question, si le patient a pris quelque chose ou pas, vous allez errer dans les diagonales. Vous allez penser à un trouble bipolaire alors que c'est un accès post-toxique d'allure maniaque, carrément un tableau maniaque.

(4:00 - 4:27)

Alors c'est quoi une addiction? Comment on définit une addiction? Idmen, comment on définit une addiction? Quels sont les mots-clés de la définition d'une addiction? La dépendance. La dépendance, ça veut dire, ça s'entend addiction. Quels sont les mots-clés de la définition de la dépendance? Addiction.

(4:28 - 4:53)

Addict dans la littérature, ça veut dire esclave. Un sujet devient addict à quelqu'un, ça veut dire qu'il devient son esclave. Donc quels sont les mots-clés? Est-ce que le patient addict peut arrêter la consommation? Donc c'est l'impossibilité d'arrêter la consommation ou bien d'arrêter le comportement.

(4:54 - 5:25)

Est-ce que le fait de dire aux gens, vous savez, l'addiction la plus fréquente, quelle est l'addiction

la plus fréquente? C'est le tabac. Est-ce que le fait de dire aux gens que le tabac donne des cancers, ça les motive, ça les stimule à arrêter? Non. Est-ce que le fait de dire aux gens que l'addiction au jeu pathologique, ça va leur faire perdre tout leur argent, leur capital économique? Non.

(5:26 - 5:46)

Donc c'est l'impossibilité d'arrêter malgré la connaissance des conséquences négatives. Elle est dans l'impossibilité d'arrêter. Et ça c'est important parce qu'après vous allez voir des patients qui vont vous dire, moi je ne veux pas arrêter pour le moment, ça me plaît toujours de consommer, je peux arrêter quand je veux.

(5:48 - 6:01)

Alors que par définition, il ne peut pas arrêter quand il veut. Ça c'est un, c'est quoi quand il dit je peux arrêter quand je veux? Une résistance ou bien le déni. Ils sont dans le déni.

(6:01 - 6:11)

Donc des gens comme ça, il faut travailler avec eux et leur déni. Ça c'est des éléments importants. Alors c'est l'impossibilité répétée de contrôler un comportement.

(6:12 - 6:32)

Il ne peut pas se contrôler, il ne peut pas arrêter le comportement et la poursuite de ce comportement malgré la connaissance des conséquences négatives. C'est pour ça que ça ne sert à rien, ça donne des cancers, ça donne ça, ça donne ça, ça donne ça. Si le patient ne le sait pas et il le demande, oui, là il faut le sensibiliser.

(6:32 - 6:43)

C'est la psycho-éducation. Parce que quand vous lui dites ça, c'est comme ce que disent les parents. Ses parents lui-même lui disent ça.

(6:47 - 7:06)

D'accord? Donc si vous dites la même chose, vous allez prendre le côté des parents. Alors il existe, comme on a dit, deux types, les addictions comportementales et les addictions aux produits. Quelles sont les addictions aux produits que vous connaissez? Les jeux vidéo.

(7:07 - 7:24)

Qui dit jeux vidéo dit Internet. Quoi d'autre? Les jeux pathologiques aussi. C'est les jeux de course.

(7:24 - 7:31)

C'est les jeux de course. Vous les connaissez. Vous les connaissez.

(7:33 - 7:39)

Les courses. Les casinos. Les jeux au casino.

(7:40 - 7:50)

Il y en a qui perdent vraiment énormément d'argent dans ces jeux-là. Il y a aussi les addictions alimentaires. Ça peut être considéré aussi comme une addiction.

(7:50 - 7:59)

Les addictions sexuelles. Les addictions à la télévision, à l'Internet, aux jeux pathologiques. Alors, toutes les deux.

(8:00 - 8:13)

Comme on a dit, elles ont un petit peu les mêmes conséquences, mais les plus graves, c'est les addictions aux produits. Alors c'est une perte de la liberté de s'abstenir aux toxiques. Au cours des années, il y a eu différentes terminologies.

(8:13 - 8:25)

On les appelait toxicomanes, alcooliques. Après, là, récemment, on parle d'addicts, d'usagers, ou bien abus de substances. On va voir les différents stades.

(8:26 - 8:45)

Alors, le neurotransmetteur responsable de cette addiction, c'est la dopamine. La dopamine, elle est appelée neurotransmetteur du plaisir. Si vous voulez, toutes les drogues font en sorte d'augmenter la dopamine au niveau de la synapse.

(8:46 - 8:56)

Et c'est ça qui va donner le plaisir. Au niveau de ce qu'on appelle plus précisément le circuit de récompense. Et c'est ça qui va procurer du plaisir.

(9:00 - 9:13)

Tout au long de l'histoire, l'être humain était à la recherche du plaisir. Il a essayé tous les moyens à la recherche du plaisir. Au début, il y a eu des moyens naturels, des plantes.

(9:14 - 9:30)

Et puis, après, il a commencé à développer les moyens, toujours à la recherche du plaisir. Toujours à la recherche des moyens de plus en plus forts pour avoir du plaisir. Il y a eu des produits qui ont été utilisés dans un but thérapeutique.

(9:30 - 9:48)

Par exemple, quoi? Là, la morphine. Même le cannabis a eu des vertus thérapeutiques contre la douleur, contre les vomissements. Au début, on l'utilisait pour des moyens thérapeutiques.

(9:48 - 10:05)

La morphine a été utilisée comme moyen thérapeutique. Il y a des gens qui font partie d'un milieu particulier qui commencent à utiliser la morphine elle-même comme produit addict. Ils deviennent addicts à la morphine.

(10:05 - 10:18)

Et de la morphine, on a extrait un produit qui est cousin de la morphine. C'est lequel? Oui, l'héroïne. L'héroïne, elle aime la morphine.

(10:19 - 10:47)

Au niveau chimique, c'est la même constitution chimique. Vous vous rappelez les constitutions chimiques des produits H₂, A, N, azote et tout ça? C'est la même constitution chimique, seulement au niveau spatial, sa disposition est différente. La morphine est fabriquée dans des laboratoires pharmaceutiques parce que c'est un médicament, mais qui donne aussi des addictions.

(10:48 - 11:04)

L'héroïne est fabriquée dans des laboratoires clandestins, donc c'est illégal. D'autres produits que vous connaissez, les benzodiazépines, c'est un médicament. C'est des anxiolytiques sédatifs.

(11:05 - 11:21)

Ils étaient découverts pour leur vertu thérapeutique, mais après leur utilisation, il a été dévié. Maintenant, il y a des patients qui ne peuvent pas arrêter de consommer les benzodiazépines. C'est pour ça que leur prescription est stricte.

(11:22 - 11:36)

Vous allez voir ça dans le cours des anxiolytiques. Il ne faut pas dépasser au maximum deux ou trois mois. La majorité des cas, on ne dépasse pas une semaine, deux semaines, des fois un mois.

(11:37 - 12:04)

Mais trois mois, c'est rare qu'on arrive à trois mois. Et il est déconseillé de les prescrire chez les patients addicts, parce qu'ils vont tomber rapidement dans l'addiction aux benzodiazépines. Alors, être addict à quelqu'un dans l'histoire, c'est quelqu'un qui doit de l'argent à une autre personne, il devient son esclave, il devient addict à cette personne, c'est-à-dire cette personne, il va l'utiliser jusqu'à ce que son argent soit remboursé.

(12:04 - 12:18)

Dans les travaux ou bien il va commencer à lui prendre de l'argent régulièrement jusqu'à ce que son argent soit remboursé. Et on dit que telle personne est addict à telle personne. C'est être esclave de telle personne.

(12:19 - 12:39)

Au début, comme on a dit, le terme a été réservé uniquement aux addictions en substance. On parlait de l'addiction à l'alcool, à la cocaïne, à l'héroïne, au tabac, mais on ne parlait pas aux addictions à la télévision comportementales et sexuelles. Mais après, on a vu qu'il y a une analogie entre les deux.

(12:40 - 13:01)

C'est quoi cette analogie ? C'est dans la répétition, c'est dans le comportement compulsif. Aller vers la drogue de façon compulsive, c'est la même chose qu'aller vers un comportement de façon compulsive. Et bien sûr, dans les deux cas, il y a une perte de contrôle.

(13:02 - 13:21)

Les gens qui jouent au casino, vous les voyez, vous avez vu dans les films, ils ne peuvent pas s'empêcher, ils ne peuvent pas se contrôler. Et vous voyez des fois des vieux qui commencent à jeter de l'argent, ils ne peuvent pas s'empêcher. Ils appellent, ils demandent de l'argent, et ils peuvent faire des choses vraiment illégales, ils peuvent voler, ils peuvent faire des choses immorales pour avoir de l'argent.

(13:21 - 13:43)

Donc, c'est la perte de ce contrôle. Les deux ont les mêmes caractéristiques, d'où on a aussi utilisé le terme d'addiction, pour les addictions au comportement que vous voyez ici, comme on a dit tout à l'heure, les différentes addictions. Alors, comme je vous ai dit, il faut s'arrêter par rapport aux différents stades de consommation.

(13:44 - 14:06)

Au début, il y a ce qu'on appelle l'usage. On parle d'usager de drogue, d'usager de produits, et ça, ça commence souvent par le tabac ou bien par le cannabis, ou bien des fois par des bières. Donc ça, c'est une consommation qui n'a pas de complications et qui n'y a pas de troubles, il n'y a pas de conséquences.

(14:07 - 14:31)

Il n'est pas considéré comme pathologique parce qu'il n'est pas nocif, sauf s'il se répète. Et en général, c'est une consommation sans lendemain et c'est une consommation sans dommage. Et ça, ça arrive des fois chez des adolescents à qui vous posez la question, est-ce que vous avez déjà consommé ? Ils vont vous dire, oui, j'ai commencé la première bouffée, j'ai vomi.

(14:31 - 14:53)

La première bouffée, ça m'a étouffée, la première bouffée, je trouvais que c'était dégueulasse, je détestais, je n'ai pas aimé. Donc, ils vont arrêter. Ou bien quelqu'un qui l'a utilisé une fois et après ça l'a angoissé, ça l'a tellement angoissé, ça lui a donné une angoisse, une panique, ou bien des tachycardie, des sines, qu'il a arrêté, qu'il a peur de revivre la même chose.

(14:54 - 15:15)

Ou bien quelqu'un qui l'a utilisé juste une fois, mais vu d'autres moyens protecteurs qu'il a, il a arrêté. Donc, il n'a plus consommé, ça c'est un usager, usage une fois. Après, quand quelqu'un l'a utilisé, il y a des gens qui vont savourer ce plaisir la première fois.

(15:16 - 15:37)

Ils vont le connaître pour la première fois et ça va être un usage par la suite qui va se répéter par la suite. Alors, dans l'usage, il y a l'usage expérimental, juste par curiosité. Quelqu'un qui veut juste savoir ce que ça va donner.

(15:38 - 15:50)

Et là, il va être dans les trois cas qu'on a dit. Soit il va détester, soit il va aimer, mais il ne voudra plus refaire, soit il va avoir peur. Donc, c'est une consommation en général sans le lendemain.

(15:50 - 16:07)

Mais ça reste une consommation à risque pour les gens qui vont aimer. Donc ça, c'est juste l'expérience, la curiosité, et ça arrive à la plupart des jeunes. Au début, on voyait que ce sont des adolescents qui commençaient à consommer, 14 ans, 15 ans, 16 ans.

(16:07 - 16:32)

Là, on voit des enfants, 10 ans, 11 ans, et même des consommations avant 9 ans, 8 ans. Donc,

ils commencent à le faire par curiosité, soit à l'occasion d'une occasion, soit pour faire la fête, pour faire comme les autres, pour être dans le groupe. Donc, ils vont aussi essayer.

(16:33 - 16:43)

Et là, ils vont rechercher cette sensation de plaisir. Il peut passer par étapes. Donc, il a utilisé la première fois pour l'expérience.

(16:43 - 17:17)

S'il n'a pas détesté, s'il a aimé, il va le refaire au cours d'une occasion. Donc, il va garder en mémoire comme quoi ça lui a donné du plaisir lors de la première expérience. Et il va l'utiliser à chaque fois qu'il y a une occasion pour avoir du plaisir, pour faire la fête, pour avoir ce bien-être, ce petit bien-être, pour avoir de l'apaisement, et pour être désinhibé, pour pouvoir parler aux filles, par exemple, ou bien pour pouvoir parler à un ami, par exemple.

(17:20 - 17:31)

Après, il va tomber dans l'usage régulier. Et l'usage régulier, il est lié à l'état psychique. Ça lui a donné un bien-être, ça lui a donné un petit peu de plaisir.

(17:31 - 17:38)

À chaque fois qu'il n'est pas bien, il va l'utiliser. À chaque fois qu'il est triste, il va l'utiliser. Et ça, c'est plus grave.

(17:38 - 17:59)

Là, les choses vont s'aggraver parce que là, il va l'utiliser comme automédication. Il ne va pas chercher une autre alternative parce que le résultat avec le produit, il est rapide. Donc, ça va rapidement l'améliorer, ça va rapidement améliorer son humeur, sa tristesse.

(18:00 - 18:19)

Après, il va tomber dans l'abus. Donc, dans l'usage, il y a trois types d'usages. Et dans l'abus, c'est là qu'il va y avoir le début des problèmes, le début des risques et là, le risque pour aller vers la dépendance.

(18:21 - 18:45)

Donc, c'est une consommation à caractère qui va être caractérisée par des préjudices, c'est-à-dire par des problèmes, par le début des problèmes, mais il n'est pas encore dépendant. Là, l'abus, c'est le début des problèmes. Mais quand on va aux critères de dépendance, on va voir qu'il ne va pas remplir tous les critères de dépendance.

(18:46 - 18:57)

Là encore, le travail peut être facile. Mais le début, c'est surtout des problèmes sociaux. Quel type de problème social va-t-il y avoir au début? Surtout là, c'est des adolescents.

(19:00 - 19:20)

Les problèmes avec les parents, la maman ou bien le papa qui vont commencer à faire des remarques par rapport aux yeux, aux larmes au moment des yeux, la rougeur des yeux, le retard quand ils rentrent tard, par exemple, la nuit. Ils vont commencer à fouiller dans ses affaires pour chercher du cannabis. Ils vont commencer à le sentir pour sentir l'odeur de l'alcool, du tabac, par exemple.

(19:20 - 19:48)

Et là, ça va commencer à créer des problèmes au sein de la famille. Les problèmes de santé, ici, ça va être que des troubles un petit peu du sommeil, par exemple, se lever tard, des problèmes d'hérédité, des problèmes de concentration, d'attention, manquer un petit peu aux exigences de la famille ou bien des absences à l'école, par exemple. Là, c'est des problèmes de santé minimes.

(19:51 - 20:05)

Après, il va rentrer dans la dépendance. La dépendance, c'est la prise compulsive, comme on a dit. C'est la possibilité d'arrêter malgré la conséquence, la connaissance des conséquences néfastes.

(20:06 - 20:29)

Alors, parmi les critères, vous allez voir que rapidement, vous pouvez obtenir deux à trois critères pour parler d'une dépendance modérée. Et aussi, on peut arriver rapidement à quatre critères pour parler d'une dépendance sévère. Alors, dans les critères, c'est l'incapacité de remplir les obligations majeures au travail.

(20:30 - 20:39)

Et bien sûr, on arrive à ce stade-là après quelques mois ou bien quelques années. Donc, il y a d'abord l'usage. Après, il y a l'abus.

(20:40 - 20:55)

Et quand on arrive à ce stade, c'est après quelques années ou bien quelques mois de l'usage et de l'abus. Donc, l'incapacité de remplir les exigences, les obligations, c'est l'absence. Alors, à l'école, il ne travaille plus, il va refaire des années.

(20:55 - 21:22)

Au niveau du travail, il va manquer les obligations de son travail ou bien il va y avoir une baisse de rendement au niveau de son travail ou bien il peut carrément être licencié de son travail. L'usage dans des situations dans lesquelles celui-ci est physiquement dangereux. Parmi les situations dangereuses, par exemple, les plus fréquentes, quelqu'un qui consomme est dans des situations dangereuses.

(21:22 - 22:00)

Qu'est-ce qu'il y a comme situation dangereuse alors que la personne consomme? La conduite d'automobile, la conduite de machine, un chirurgien qui opère alors qu'il consomme, d'accord? Il y en a un anesthésiste qui consomme et qui travaille, une femme enceinte. Ça aussi c'est une situation à risque. Et la poursuite, ça, vous le savez, malgré la connaissance des problèmes sociaux interpersonnels, la tolérance, ça aussi c'est un problème qui est important, qui va augmenter le risque.

(22:00 - 22:21)

Au début, vous allez voir, en clinique, on le voit, ils vont consommer avec une joie, deux joies, avec une bière, deux bières, mais après ça ne suffit plus pour avoir le même effet. Donc ils vont augmenter les quantités de substances pour avoir le même effet, pour rechercher le même effet. Et là, la dépendance s'aggrave.

(22:22 - 22:51)

Et bien sûr, l'effet diminue lors de l'usage continu, quand ils vont continuer, l'effet va diminuer au lieu de consommer une fois par semaine, il va continuer à consommer deux fois par semaine, après trois fois par semaine, après chaque jour. Ça c'est la dépendance. Le syndrome de sevrage, c'est ça qui fait peur aux addicts, ils ne voudront pas tomber, ils ne voudront pas arrêter pour ne pas tomber dans le syndrome de sevrage.

(22:51 - 23:37)

Le syndrome de sevrage, qui est caractéristique pour chaque substance, donc par exemple pour l'alcool, après le sevrage, quel est le symptôme le plus fréquent ? Un patient qui consomme, il ne consomme plus. Qu'est-ce que vous constatez en l'observant ? Qu'est-ce qu'il présente ? Vous êtes là avec lui, qu'est-ce que vous observez ? Quand il veut, par exemple, toucher quelque chose, ou bien quand il veut vous saluer. Le tremblement de la main, surtout le matin, parce qu'ils sont au sevrage toute la nuit, donc ça c'est capital.

(23:38 - 23:53)

Le cannabis c'est l'irritabilité, la nicotine, vous le voyez le Ramadan ? Qu'est-ce qu'il y a pour la

nicotine ? Le tabac. Les gens qui fument, on ne leur parle pas la journée. Donc c'est l'irritabilité, la nervosité.

(23:55 - 24:36)

C'est pour ça qu'après quelques heures, ça dépend de chaque substance, par exemple l'alcool, le lendemain dès le réveil, il commence à consommer, pour éviter les symptômes de sevrage. Il va y avoir l'intérêt d'expliquer aux patients la durée de ce symptôme de sevrage. Alors les substances prises en quantité plus importante et pendant une durée plus longue, parce que l'effet diminue, le désir persistant avec effet infructueux pour arrêter ou contrôler l'usage de la substance, le désir est tout le temps là, et même s'ils font des efforts, ils n'arrivent pas.

(24:37 - 25:07)

Beaucoup de temps, ils passent beaucoup de temps à consommer, ou bien à chercher le produit, comment le procurer, comment avoir l'argent, comment le cacher pour le faire rentrer à la maison, comment se cacher pour le consommer avec les amis. Donc beaucoup de temps dans ça, on dépend d'autres choses plus importantes, notamment la famille, les loisirs, le travail, le bonheur de toute la famille. Alors l'usage de la substance malgré l'existence de problèmes physiques ou psychologiques.

(25:07 - 25:48)

Et le 11e, c'est quelque chose aussi de très important, c'est le craving, ou bien le désir fort, ou bien la pulsion de consommer. Ça c'est la dépendance psychique, parce que la dépendance physique, c'est tout ce que ressent le patient physiquement à l'arrêt de la substance. Les tremblements, l'irritabilité, la nervosité, la tachycardie des fois, la sécheresse de la bouche des fois, les sueurs, ça c'est les douleurs, ça on va le voir avec surtout un type de drogue, les douleurs abdominales, les douleurs lombaires atroces, ça, ça peut disparaître en fonction des produits, quelques jours ou bien une ou deux semaines après le produit.

(25:48 - 26:25)

Mais ce qui persiste par la suite, c'est ce craving, c'est cette envie, cette pulsion psychique de consommer à chaque fois qu'on voit la substance, à chaque fois qu'on entend la substance, à chaque fois qu'on passe devant un bar, qu'on voit un ami avec qui on a consommé, qu'on voit un café, qu'on passe devant un café, des choses qui nous rappellent, d'accord ? La consommation, ça, ça reste des choses difficiles à traiter et ça, c'est le suivi à long terme, c'est la psychothérapie à long terme. Comme je vous ai dit, dans la dépendance, il y a psychique et physique. Physique, c'est surtout les douleurs, ça vous le voyez dans les films.

(26:26 - 27:04)

Vous voyez dans les films, les patients addicts à l'héroïne, quand on les oblige à arrêter dans des

centres de désintoxication, là vous voyez les douleurs qu'ils ont, les douleurs abdominales, les douleurs lombaires, ce sont des douleurs atroces et insupportables. Avec l'héroïne, le tremblement avec l'alcool et surtout avec les benzodiazépines et avec les barbituriques et même avec l'alcool, on va le voir dans le cours de l'alcool, le risque de convulsions. C'est pour ça qu'il y a des produits qu'on ne doit pas arrêter brutalement.

(27:05 - 27:25)

Par exemple, les benzodiazépines, on peut se permettre et il faut, quand on vous les donne à un patient, il faut les arrêter progressivement. Vous suivez un schéma pour les arrêter parce que le patient risque de faire des convulsions ou bien des crises d'épilepsie. L'alcool, bien sûr, on l'arrête.

(27:25 - 28:11)

On va voir par la suite selon les écoles, mais on ne va pas faire avec l'alcool, l'héroïne, le cannabis et la cocaïne arrêter progressivement, non. Pour éviter les convulsions ou bien les crises d'épilepsie qu'on peut avoir avec l'alcool parce que l'alcool, il agit sur les récepteurs gabaergiques, les mêmes récepteurs où agit le benzodiazépine. Donc, pour éviter les crises convulsives et les crises d'épilepsie dues à l'arrêt de l'alcool, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas arrêter l'alcool progressivement, dire au patient, vous prenez aujourd'hui quatre bières, demain trois bières, après demain deux bières.

(28:14 - 28:31)

Très bien. On peut le mettre sous benzodiazépine, c'est un médicament, et après on diminue le benzodiazépine progressivement. Ou bien on peut le mettre sous un antiépileptique, la carbamazépine ou bien l'hépaquine, pour éviter les crises épileptiques.

(28:35 - 29:00)

Alors, la dépendance psychique, c'est ce que j'ai dit, c'est ce qui est plus difficile à arrêter et c'est ce qu'on va arrêter, on va aider le patient avec des psychothérapies. Donc, c'est une impossibilité de résister aux besoins de consommer qui s'imposent au patient et, bien sûr, une perte de contrôle de soi et qui reste la plus difficile à traiter. Il faut le reconnaître.

(29:00 - 29:26)

Quand le patient vous dit que c'est impossible, que c'est difficile, il faut le reconnaître. Je sais que c'est difficile et c'est difficile. Alors là, en résumé, les différents stades de consommation, on a dit, il y a l'usage par expérimentation, il va juste voir par curiosité ce que ça va donner, besoin de nouvelles expériences ou bien pour avoir de nouvelles sensations.

(29:26 - 29:41)

Et il y a des gens à risque à faire ce début-là et à chercher par curiosité ce que ça va donner. On va les voir. Donc, ces gens, il faut les détecter à l'avance pour les sensibiliser.

(29:41 - 30:02)

Après, il passe à l'usage occasionnel, c'est la recherche du plaisir. Donc, qu'il a eu la première fois par curiosité et il va l'utiliser à chaque fois qu'il y a une fête ou bien qu'il est avec les amis et, bien sûr, à chaque fois qu'il est triste. Après, ça va être l'abus.

(30:03 - 30:36)

Et dans l'abus, bien sûr, c'est dans des cas particuliers, quand il est dépressif, quand il y a des conflits, quand il y a une carence, pour compenser le besoin en dopamine naturel parce qu'on va le voir, il y a des choses qui vont nous donner de la dopamine naturelle. Et chaque jour, vous devez voir, est-ce que vous avez eu votre dose de dopamine journalière par les moyens, bien sûr, naturels. Donc, s'il n'a pas sa dose par façon naturelle, il va la chercher de façon, par les produits.

(30:36 - 30:57)

Et après, il va tomber dans la dépendance avec la perte de la maîtrise et avec l'apparition des conséquences psychiques et des conséquences physiques, sociales et professionnelles et familiales. Là, je vous donne aussi le même schéma pour l'étude qu'on a parlé. C'est une enquête nationale qui a été faite à l'échelle du Maroc.

(30:58 - 31:11)

C'est la seule étude intéressante en psychiatrie parce qu'elle a concerné quand même 6 000 sujets. La seule étude qui a concerné un grand nombre de sujets. Là, vous voyez la consommation qui reste quand même.

(31:11 - 31:24)

On a étudié l'abus de substances, toutes substances confondues. Vous imaginez que si on a des taux élevés, c'est à cause de quelles substances? Le tabac. Donc, la majorité consomme du tabac.

(31:25 - 31:40)

Donc là, c'est les chiffres marocains. La dépendance actuelle durant l'année, on a posé au sujet, c'est 1 à 1%. Donc, pour 100 personnes, il y a 1 qui a une dépendance dans l'année.

(31:41 - 31:52)

L'abus dans 100 personnes. Deux, ils ont l'abus, l'utilisation de drogues, toutes drogues

confondues. Quatre dans 100 personnes et ainsi de suite.

(31:56 - 32:12)

Alors, par rapport à la population générale, donc toutes substances confondues, le taux de mortalité, il peut aller de 0,5 à 3,5%. Donc, 3%, si on peut dire, 3 personnes dans 100 personnes. C'est beaucoup quand même.

(32:13 - 32:30)

Et bien sûr, la mortalité, elle est due, dans la majorité des cas, à l'utilisation de produits. C'est pour ça qu'actuellement, vous voyez, tous les états ne vont pas dans l'éradication totale de la consommation. On ne peut pas éradiquer.

(32:30 - 32:51)

Les produits, ils sont là, ils sont fabriqués et on continue à les fabriquer et on découvre de nouveaux produits. Là, si vous voyez les patients addicts, vous allez voir qu'ils connaissent mieux que vous les produits et mieux que vous comment on les utilise et les associations qu'on utilise. Là, on voit qu'il y a de nouveaux produits chaque fois.

(32:52 - 33:17)

Il y a l'apparition de nouveaux produits. Donc là, pour éviter les complications mortelles, on va vers la prévention des complications, la prévention des risques. Notamment, par exemple, on va utiliser des centres pour donner le matériel aux consommateurs.

(33:17 - 33:32)

On va jusqu'à leur donner les seringues pour ne pas échanger les seringues entre eux. On va jusqu'à leur demander de venir et d'utiliser un matériel stérile pour ne pas échanger le matériel entre eux. D'accord ? Donc ça, parce qu'on n'arrivera pas à éradiquer.

(33:33 - 33:40)

Soit la mort, elle est due à un surdosage, c'est l'overdose. Ça, c'est plus fréquent. Et ça, on le voit dans toutes les populations.

(33:41 - 33:56)

On le voit chez les médecins, chez les infirmiers, chez les hommes, même d'un niveau intellectuel. Et à chaque fois, je pense que vous avez déjà entendu parler des médecins qu'on a trouvés morts dans leur appartement seul, des infirmiers, des anesthésistes. Donc ça, tous les niveaux.

(33:57 - 34:19)

Soit par le suicide, soit que ça se complique par une dépression, et de là par le suicide, soit c'est faire un surdosage dans un but suicidaire. Le surdosage peut être fait juste pour chercher le plaisir par consommation, comme ça le sujet est le seul de façon impulsive, soit dans un but suicidaire. Ou bien par les infections.

(34:19 - 34:39)

À part le sida, il y a des infections hépatiques. Alors les facteurs de risque, ça c'est très important parce que ça va vous permettre de détecter les gens qui consomment, ou bien de sensibiliser les gens, ou bien de faire la prévention. Il y a des facteurs de risque qui sont liés aux produits lui-même.

(34:40 - 34:49)

Il y a des produits qui sont plus addictifs que d'autres. Dès que le sujet commence à les consommer, il les chope. Et il y a des produits qui sont moins addictifs.

(34:49 - 35:01)

Il y a des facteurs qui sont individuels, liés à la personne elle-même. Il y a des facteurs qui sont liés à l'environnement. Et dans les facteurs de risque, c'est les trois.

(35:02 - 35:17)

Comme vous voyez, c'est une équation où on a la multiplication des trois. Il n'y a pas uniquement le produit disponible, ou bien très addictif. Il y a aussi parce que c'est cette personne-là, et parce que c'est ce milieu-là.

(35:18 - 35:39)

Donc, on va prévenir les trois. Et on va aller dans les détails. Par rapport aux produits, quel est le produit le plus addictif? Non, le produit le plus addictif, ça va de soi.

(35:39 - 35:48)

C'est le produit le plus fréquent. C'est le tabac. Ce n'est pas parce qu'il est moins cher, mais le cannabis, c'est le même prix.

(35:49 - 36:01)

Il y a des boîtes de cigarettes qui coûtent cher. Donc, le tabac, c'est le plus addictif. Et vous voyez que la plupart des gens qui consomment un seul produit, c'est le tabac.

(36:02 - 36:19)

D'accord? Et la plupart des jeunes, ils commencent par le tabac. Donc, le tabac, c'est le produit. Il y a des consommateurs de tabac parmi vous? Alors, le tabac, c'est le produit le plus addict.

(36:19 - 36:29)

Dès que la personne commence à le consommer, elle devient addict. En plus, c'est facile. Pour l'acheter, c'est facile.

(36:29 - 36:37)

Et puis, ça ne nécessite pas une préparation. Pour le consommer, c'est facile. Donc, c'est facile de le répéter la consommation.

(36:37 - 36:43)

Il va le consommer la première fois. Il va avoir une sensation. Peut-être la première fois, c'est toujours.

(36:43 - 36:52)

Vous avez tous été consommateurs de tabac de façon passive. Chez vous ou bien dans des cafés. Donc, la première fois, vous ne supportez pas.

(36:52 - 37:00)

Mais après, vous vous habituez. Même chez vous. La première fois, quand quelqu'un consomme devant vous, vous dites, non, sortez, consommez à l'extérieur.

(37:00 - 37:07)

Je ne supporte pas la fumée du tabac. Mais progressivement, vous supportez. C'est la même chose qui va arriver à un addict.

(37:07 - 37:14)

C'est vrai, la première fois, il ne peut pas supporter la fumée. Ça peut l'irriter un petit peu au niveau de la gorge. Mais il va essayer la deuxième fois parce que c'est facile.

(37:15 - 37:22)

Il peut prendre une clope de chez un ami. Et là, il va tomber dans la dépendance. Le deuxième produit, c'est l'héroïne.

(37:22 - 37:31)

Et après, la cocaïne parce qu'ils vont donner un plaisir. Donc, l'héroïne, ça sédate. Quand on vous dit l'héroïne, pensez à la morphine.

(37:32 - 37:57)

L'effet recherché par rapport à l'héroïne, c'est vraiment cette sensation de sédation, d'apaisement. Et quel est l'effet recherché par la cocaïne? L'hypervigilance, dans ce sens, c'est quoi? L'euphorie, l'excitation. Alors, il y a des gens qui vont consommer la cocaïne au début.

(37:57 - 38:20)

Ils vont avoir cette euphorie, cette excitation, cette joie, cette vraiment hyperactivité. Et après, pour se calmer, ils vont consommer de l'héroïne. Après, il y a le risque d'apparition de complications sanitaires ou psychologiques ou sociales qui sont dues aux produits et qui vont les pousser à consommer.

(38:20 - 38:42)

Par exemple, l'alcool, au début, il est anxiolytique parce que, vous voyez, les gens qui consomment de l'alcool, si une consommation est modérée, ça peut les calmer. Ça peut apaiser l'angoisse parce qu'au début, il est anxiolytique, l'alcool. Il agit sur les récepteurs benzodiazépiniques.

(38:42 - 38:53)

D'accord? Donc, ça calme l'alcool. Et les alcooliques, en général, sont gentils. Tu vois, les alcooliques sont gentils, ils sont calmes au début.

(38:53 - 39:16)

Avant, on ne parlait pas des complications. Donc, quand ils vont le consommer, au début, il est anxiolytique. Mais après, on va voir le mécanisme, après il devient anxiogène et il devient dépressogène parce qu'il va déséquilibrer le turnover de nos adrénalines, du sérotonine.

(39:16 - 39:35)

Alors, quand il va devenir anxiogène et dépressogène, le sujet, il va commencer et recommencer, répéter à le consommer pour diminuer la dépression et l'anxiété. Et il va rentrer dans un cercle vicieux. L'alcool va donner l'anxiété, va donner la dépression.

(39:36 - 39:49)

Lui, il va continuer à rechercher, à calmer cette anxiété et cette dépression. Donc, il va rentrer dans un cercle vicieux. Donc, la dépendance, elle est due à la complication du produit.

(39:50 - 40:22)

Et il y a des produits qui donnent plus de dépendance par leur complication sociale. Le plus fréquent, je ne l'ai pas bien mis ici, qui donne de la marginalisation, de la désocialisation et de la délinquance, c'est quoi ? C'est le crack, bien sûr. Mais c'est quoi le plus fréquent chez nous, le plus connu chez nous, qui donne de la marginalisation, la désocialisation, la délinquance ? Il y a un mot que vous connaissez en arabe.

(40:26 - 40:46)

Comment on les appelle ? « Agulu » « Mahia » « Mahia », c'est de l'alcool. Mais c'est vrai, parce que c'est... C'est qui qui consomme le « mahia » ? Les gens que vous voyez dans la rue. Parce que ce n'est pas cher, ce n'est pas trop cher.

(40:47 - 41:00)

Donc, les gens que vous voyez dans la rue, comment vous les appelez ? Ils sont marginalisés, ils sont désocialisés, ils sont délinquants. SDR. Sans difficulté financière.

(41:06 - 41:25)

C'est la désocialisation, délinquance, la marginalisation. Qu'est-ce qu'ils consomment le plus ? La sélection, l'alcool synthétique. C'est l'alcool, d'accord ? C'est la sélection.

(41:25 - 41:37)

Alors, quelqu'un qui consomme l'alcool synthétique, il est marginalisé. Il voit sa vie finie. Il n'y a pas d'avenir.

(41:39 - 41:55)

Donc, cette marginalisation va pousser à faire quoi ? À continuer à consommer. Pour oublier sa marginalisation, sa désocialisation, sa délinquance. Alors, pourquoi ils consomment ? Pour qu'ils aiment.

(41:58 - 42:10)

Pour qu'ils aiment, pour qu'ils ne ressentent pas ce monde. Pour qu'ils ressentent ce qu'ils disent. Sur quoi ? Dites-le.

(42:11 - 42:25)

Sur les nuages. Vous savez des choses. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ce sont des mots que vous devez savoir.

(42:25 - 42:46)

Parce que quand un adolescent vient vous parler de ça, il va utiliser ces termes. Et vous, bien sûr, vous devez être au courant. Parce que comment il va vous dire que ça donne du plaisir ? Vous ne savez pas ce que ça donne ? Ben oui, ça donne du plaisir.

(42:47 - 42:57)

Sinon, pourquoi on va le consommer ? Pourquoi on va tomber dans la dépendance si ça ne donne pas du plaisir ? Vous n'allez pas lui dire non. Ça donne des cancers. Mais avant de donner des cancers, ça donne du plaisir.

(43:00 - 43:14)

Donc, quelqu'un qui est marginalisé par une substance, il va continuer à la consommer pour oublier sa marginalisation, sa désocialisation. Donc, le produit lui-même peut provoquer cette dépendance. Et il y a bien sûr des facteurs génétiques.

(43:14 - 43:31)

Ça, c'est très important. Qui dit facteur génétique dit facteur biologique. C'est des gens qui vont, par rapport à la réponse, par rapport au métabolisme, par rapport à la sécrétion de dopamine, qui vont répondre beaucoup plus par rapport aux autres.

(43:33 - 43:42)

Et ça, c'est très important de le connaître. Parce qu'il y a des jeunes qui vont vous dire ça ne va rien me faire. Rien ne va m'arriver.

(43:43 - 44:00)

Mon voisin, mon cousin, il consomme depuis des mois, depuis des années et il est toujours bien. Il n'a pas de cancer, il n'est pas marginalisé, il n'a pas de problème de santé, il n'a pas de dépression, il n'a pas d'irritabilité, il est bien. Alors oui, lui, il est bien.

(44:01 - 44:18)

Mais vous, je ne sais pas si vous avez la même génétique, si vous avez la même réponse biologique que lui. Parce qu'on n'est pas tous égaux vis-à-vis des drogues. Une personne X peut le prendre, c'est vrai.

(44:18 - 44:39)

Il peut le prendre le 1er juin et rien ne va lui arriver. Une autre personne Y, le 1er juin, il peut faire un accès psychotique X. Et ça arrive, les expériences paranos, ça arrive. Ça arrive, des gens,

quand ils prennent le 1er juin, ils ont cet effet parano.

(44:40 - 45:02)

C'est quoi l'effet parano, le 1er juin? C'est on me surveille, on me poursuit, il y a des gens qui prennent le 1er juin, ils sortent, ils me suivent, il y a des gens derrière les caméras, ils me suivent. Il n'y a pas de méfiance. Quand quelqu'un entre dans la maison, il y a quelqu'un qui se voit, il y a un peu d'angoisse psychotique.

(45:03 - 45:16)

Comme l'angoisse qu'on trouve chez les psychotiques. Ça, c'est de la méfiance, c'est ce qu'on appelle l'effet parano. Donc si quelqu'un fait cette expérience après la première prise d'un produit, ça veut dire qu'il est vulnérable.

(45:18 - 45:40)

Il ne doit jamais toucher à la drogue. Le 1er accès psychotique, il peut passer sans lendemain, mais il y a 4 façons d'évoluer après un 1er accès psychotique. Soit sans lendemain, mais pour le savoir, il faut surveiller la personne pendant 2 ans, il doit rester clean sans symptômes pendant 2 ans.

(45:42 - 46:21)

Soit il peut y avoir répétition des accès psychotiques, soit il peut évoluer vers un problème psychotique chronique, soit un trouble bipolaire. Si les symptômes au début étaient plus d'allure maniaque, soit il peut évoluer vers une schizophrénie si les symptômes au début étaient plus dissociatifs, ou il y avait plus de bizarreries de comportement. Ceci dit, je ne dis pas que les drogues vont causer une schizophrénie ou un trouble bipolaire, mais elles sont tombées chez une personne qui est vulnérable.

(46:22 - 46:57)

Et comme j'ai dit, rappelez-vous les 3 facteurs, génétique, biologique, personnel, environnemental, et après le produit. Donc le sujet peut-être allait devenir un bipolaire, allait devenir un schizophrène, mais le produit a précipité l'arrivée du trouble. Et si le trouble arrive de façon précoce, vous savez qu'il est de mauvais pronostic.

(46:58 - 47:18)

C'est pour ça que les sujets que vous détectez vulnérables, il faut les sensibiliser. Ça n'a pas donné un accès psychotique chez le voisin, ni chez le cousin, ni chez votre frère, mais ça vous a donné un accès psychotique aigu, donc vous ne devez plus toucher. Vous êtes à risque, vous êtes vulnérable.

(47:19 - 47:45)

Alors, bien sûr, les autres facteurs, à part le produit, il y a les facteurs individuels, tout ce qui est trait de personnalité. Faible estime de soi, timidité, autodépréciation. Là, c'est des gens qui vont chercher à améliorer leur personnalité, leur trait de personnalité par les drogues, parce qu'on sait que les drogues vont donner un bien-être, vont donner une désinhibition et vont donner de l'excitation.

(47:46 - 48:19)

Le sujet aura de la facilité à aborder les gens, de la facilité à parler, de la facilité à s'affirmer. Donc ça, si on a des personnalités comme ça, ils vont répéter la prise à chaque fois qu'ils auront l'occasion de rencontrer des gens. Difficulté à réagir face à des événements, quelqu'un qui ne sait pas faire face aux événements, qui n'a pas les stratégies dont on va parler dans la thérapie, les stratégies de coping pour faire face à un problème, pour gérer le problème.

(48:19 - 49:56)

Et ça, bien sûr, chez les personnes qu'on suit, les personnes addictes, on cherche, s'ils ont ces traits-là, en leur posant la question, d'habitude face à un problème, comment vous réagissez ? Dites-moi, si vous avez ce genre de problème, on leur pose un problème, dites-moi comment vous allez réagir. Imaginez que vous êtes devant ce problème, comment vous allez réagir ? Le tempérament aussi, il y a des personnes, et ça vous le voyez autour de vous, qui ont un niveau élevé de recherche de sensations et de nouveauté, un faible évitement du danger, un faible niveau de sociabilité. Comment vous le voyez autour de vous, ce faible niveau d'évitement du danger, la recherche de sensations de nouveauté, comment vous le voyez ? Ça vous arrive des fois ? Comment on voit ? Comment on peut l'avoir ? Comment on peut l'avoir ? Dans les jeux, quand les bouches s'ouvrent, les parachutes, les jeux, quand Monsieur le Palonza à l'Inde, Disney, ou quelque chose au cinéma, les jeux, il y a des gens qui ne sont pas satisfaits, et le dessin du jeu, ça ne m'a pas donné un effet, le fait que je recherchais, ça ne m'a rien fait.

(49:56 - 50:36)

Quand j'ai vu quelqu'un descendre, je l'ai fait une fois avec mon fils, et quand on rentre, vous voyez, c'est comme l'Himalaya, quand vous commencez, vous ne pouvez pas arrêter. Je l'ai arrêté une fois, il a démarré, il a arrêté, sur place. Mais une fois, vous avez déjà été ou là à l'eau, quand il démarre, vous ne pouvez pas l'arrêter.

(50:37 - 50:55)

Dans la fusée, quand il a démarré, vous ne pouvez pas arrêter, impossible d'arrêter. J'ai eu l'impression que je suis morte, je me suis dit que j'étais morte. Je me suis dit que j'étais morte.

(50:56 - 52:05)

Alors, alors, on a fermé les yeux, quand on a fait, on a fini, quand on s'est arrêté, j'ai commencé à vomir. Je peux recommencer. Il voulait recommencer, et il a crié sur moi, pourquoi je lui ai demandé de fermer les yeux, parce qu'il n'a pas vu les sensations, parce que vous voyez que dans l'espace, vraiment, alors il y a des gens, imaginez, quand je vois des gens qui descendent de ça, ils ne sont pas satisfaits, vraiment, ils recherchent des sensations fortes, avec la drogue, mais avec le plaisir, il y a des gens qui vont se contenter de minimum de plaisir, de minimum d'euphorie, mais il y a des gens qui vont chercher plus, la recherche du danger, le faible évitement de danger, les parachutes, les élastiques, les adolescents qui cabrent, mais vraiment, alors ça ne lui suffit pas de monter juste un petit peu, tu brilles carrément derrière.

(52:06 - 52:41)

Donc ça, les gens, avec le génétique particulier, avec un environnement particulier, on voit déjà avec la personne particulière, le risque est le plus élevé. Donc dans les observations de la technologie, on cherche tous ces facteurs pour savoir à qui on a affaire et le travail qu'on va faire avec la personne. Alors le trouble de comportement aussi, si une personne a un trouble de comportement, déjà lui, il a de l'impulsivité, de l'agressivité, il est bagarreur, il a de la violence, donc c'est quelqu'un aussi qui est à risque à aller vers les produits.

(52:42 - 53:50)

Les personnes qui ont des troubles affectifs, les troubles de l'humeur, les troubles dépressifs, ce sont aussi des personnes à risque parce qu'elles vont chercher à calmer leur problème par les produits, surtout s'ils ont essayé le produit une fois et ça leur a donné du plaisir. Il y a aussi des facteurs en rapport avec les événements de vie, tout ce qui est deuil, tout ce qui est rupture, tout ce qui est maltraitance, tout ce qui est abus sexuels pendant l'enfance, absence de domicile fixe, la présence de maladies somatiques graves, ça c'est très important parce que vous le cherchez au niveau du dossier, vous cherchez les antécédents des patients et c'est quelque chose qui va pérenniser la consommation, qui ne va pas aider à l'abstinence, surtout l'abstinence psychique. Donc tout ça doit être traité, si quelqu'un a un trouble anxieux, un trouble du sommeil, un trouble de conduite alimentaire, des troubles de douleur par exemple, donc c'est des signes qui vont pérenniser la consommation.

(53:50 - 54:50)

Donc vous n'allez pas traiter uniquement la consommation mais aussi tout ce qui est sous-jacent, c'est pour ça qu'il faut faire le tour. Alors la famille aussi, les liens familiaux, une cellule éclatée, le père qui écharra contre la mère, donc si les parents ne sont pas d'accord pour l'éducation de l'enfant, ils montrent ce désaccord devant les enfants, devant l'adolescent. Bien sûr, vous savez que les enfants, les adolescents, ils profitent du désaccord des parents, donc ils vont profiter

pour avoir tout ce qu'ils veulent.

Aussi quand il y a des conflits, quand il y a de la violence, quand il y a des maladies psychiques chez la famille, donc c'est un facteur. Quand il y a des événements traumatiques, le style d'éducation, donc il ne faut pas être trop négligent et il ne faut pas être aussi trop ferme. Les enfants comme les adolescents, ils ont besoin de limites.

(54:50 - 56:42)

Quand on ne leur fait pas de limites, ce n'est pas parce qu'on fait des limites, on fait des règles, on est un petit peu ferme que c'est une pénitence pour l'enfant. Au contraire, ça les rassure. Imaginez, par exemple, je vous donne une voiture sans permis de conduire.

Est-ce que vous allez conduire à l'aise? Vous allez être angoissé, vous allez être perturbé. Le permis de conduire, c'est les règles, c'est les limites que donnent les parents. Les enfants, ils sont perdus, même les adolescents, ils sont perdus.

Quand un adolescent rentre chez lui, il voit son père, par exemple, il consomme et lui, il essaie de consommer et personne ne lui dit rien. Il va être angoissé, ça l'angoisse. Ma famille, est-ce qu'elle fait attention à moi, est-ce qu'elle ne fait pas attention à moi? Mais quand quelqu'un fait des limites, ça, ça les rassure.

On a besoin de limites quand on est enfant adolescent. On a besoin d'une guidance. Et les parents aussi, ils ont besoin de donner l'exemple.

Parce que les enfants, ils sont des éponges, comme on dit, et les enfants, ils imitent le comportement et pas les paroles. Un père qui consomme, donc l'enfant, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le père qui consomme, il va faire comme son père, mais il ne voit pas que son père lui dit de ne pas consommer. Il n'écoute pas ça.

Il écoute les comportements. Il n'écoute pas les paroles. C'est pour ça que les parents doivent être un modèle.

La pression des amis, ça c'est par rapport à l'environnement. Pour être dans le groupe, pour être avec le groupe, je dois consommer. Et ça c'est très important parce qu'au début, qu'est-ce qu'on conseille surtout aux enfants, aux adolescents, c'est d'éviter complètement les amis qui consomment.

(56:42 - 57:00)

Éviter, ça on le fait même pour l'adulte, éviter au début complètement les endroits qui nous rappellent, les amis qui nous rappellent la consommation. On va faire l'évitement. C'est vrai que vous allez entendre dans les troubles anxieux que l'évitement n'est pas conseillé, mais dans les addictions, au début, l'évitement est conseillé.

(57:01 - 57:19)

Vous devez éviter tous les amis qui consomment. J'ai eu un patient hier que j'ai vu, tous ses amis consomment. Même à l'école, tout le monde consomme.

Alors l'évitement, il m'a dit, je dois éviter tout le monde. J'ai dit oui, vous évitez tout le monde. Je dois m'isoler chez moi, m'enfermer chez moi.

(57:19 - 57:33)

Oui, vous vous enfermez chez vous. La première fois, oui. Lui, il est dans l'aide.

Maintenant, il est motivé, donc il veut des astuces, il veut savoir. Donc quand je lui dis ça, c'est parce que lui, il est d'accord. Oui, il doit arrêter, il doit éviter.

(57:34 - 57:45)

Après, quand il va être armé, on va faire avec lui la thérapie par exposition progressive. Donc aller, et après, on va voir dans la thérapie comment faire. Aller, mais ne pas consommer.

(57:46 - 58:02)

Aller dans des endroits qui lui rappellent la consommation de façon progressive sans consommer. Alors quand il y a des repères sociaux, le chômage, l'absence de valeur morale, ça ne sert à rien de respecter la loi. Toute ma vie, j'ai respecté la loi, ça ne m'a rien donné.

(58:03 - 59:01)

Voilà, j'ai perdu mon emploi, je ne trouve plus d'emploi. Donc ça, ça ne sert à rien de respecter la loi, elle va consommer. L'exclusion scolaire, l'absence d'encadrement pédagogique, l'absentéisme, le retard, la phobie scolaire, la marginalisation, tout ça, c'est des facteurs.

L'exclusion scolaire, je ne sais pas si vous vous rappelez de la période où il y avait beaucoup d'exclusions aux primaires. Vous vous rappelez de cette période ? Je vais vous donner un exemple. Il y avait beaucoup d'exclusions scolaires avant le collège.

Beaucoup. Après, à un moment, on avait redemandé la réintégration de tous les enfants qui ont été exclus. Vous avez entendu parler de cette phase ou pas ? Maintenant, on n'entend pas d'exclusion dans les primaires.

(59:01 - 59:32)

Mais avant, il y avait des exclusions. Je ne suis pas si vieille que ça. D'accord ? Alors il y avait beaucoup d'exclusions.

(59:32 - 59:44)

Et là, je me rappelle, par rapport à l'exclusion familiale, j'ai eu une patiente addictive. Elle travaillait dans un bar. C'était une barwoman.

(59:46 - 1:00:02)

Et elle était addictive au cannabis. Pas à l'alcool, mais au cannabis. Et elle travaillait très bien.

Elle a même gagné des compétitions même par rapport aux hommes. Et elle était addictive au cannabis. Et elle avait ses amis addicts avec elle.

(1:00:02 - 1:00:14)

Et là, elle est venue, elle est motivée, elle veut arrêter. Et elle m'a dit à un moment, ce qui m'a sauvée, c'est que mes parents ne m'ont jamais chassée de la maison. Ne m'ont jamais exclue de la maison.

(1:00:14 - 1:00:31)

Parce que là, vous le voyez des fois des parents. Elle, elle m'a dit, ça m'a sauvée. Elle rentrait des fois à trois heures du matin, à quatre heures du matin, elle trouvait un foyer au dormir.

(1:00:32 - 1:00:53)

Et elle m'a dit même, elle ramenait même ses amis avec elle. Les filles qui ont été chassées par leurs parents. Elle les ramenait même des fois avec elle à la maison.

Et elle m'a dit ça, ça m'a sauvée. Parce que c'est une question de facilité. C'est votre fils.

(1:00:53 - 1:01:46)

Si il avait une schizophrénie, s'il avait un diabète, s'il avait un problème cardiaque, vous allez lui dire, je vais vous chasser de la maison. Non, pourquoi? Parce que diabète, schizophrénie, hypertension, ce sont des maladies. Et bien l'addiction aussi c'est une maladie.

Est-ce que c'est une maladie ou là c'est pas une maladie? C'est une maladie. Il y a des médecins qui n'acceptent pas de dire que c'est une maladie. Il y a des médecins même qui refusent de traiter les addicts.

C'est une maladie. Dès qu'on devient dépendant, elle est dans l'impossibilité d'arrêter et la besoin d'aide. Un tabagique, vous avez des tabagiques autour de vous, vous avez vos parents, vos frères.

Tabagiques, est-ce qu'ils peuvent arrêter? Ils peuvent pas arrêter, ils sont dans l'impossibilité

d'arrêter. Donc c'est une maladie. Vous allez me dire, ils l'ont cherché.

(1:01:52 - 1:02:18)

Ils l'ont cherché, mais il y a des facteurs. Des facteurs biologiques, génétiques, des facteurs environnementaux, des facteurs en rapport avec le produit. La première utilisation, c'est vrai qu'il y a des facteurs qui l'ont poussé à ça.

C'est pas n'importe qui qui va être addict. Il a des facteurs, il a des problèmes qui vont le pousser à l'addiction. Après, quand il va tomber dans la dépendance, ça y est, il est addict, il est malade.

(1:02:19 - 1:02:54)

On doit le traiter. D'accord? Je répète encore une fois, les trois facteurs internes, environnementaux, qui vont pousser le sujet à la première expérimentation et de là, il va tomber dans la dépendance, dans la maladie d'addiction. Comme il y a des facteurs de vulnérabilité, des facteurs de risque, il y a des facteurs de protection qu'il faut dire aux patients, qu'il faut les faire sortir du patient.

(1:02:55 - 1:03:05)

Vous êtes intelligents quand même. Juste dire ça. Vous êtes intelligents pour consommer, non? Vous êtes intelligents, vous avez un niveau d'intelligence élevé.

(1:03:06 - 1:03:28)

Comment vous pouvez utiliser votre intelligence pour quelque chose de positif? Comment on peut faire pour utiliser votre intelligence pour quelque chose de positif? C'est quelqu'un qui a une capacité à résoudre les problèmes. On va l'encourager dans ce sens. C'est quelqu'un qui a des compétences sociales, une estime de soi suffisante, satisfaisante.

(1:03:28 - 1:03:36)

Je n'ai pas besoin de consommer pour être avec les amis. Je peux être avec eux sans consommer. Je suis sûr de ce que je vaud.

(1:03:37 - 1:03:55)

S'il a un soutien familial adapté, quand je dis la patiente qui n'a pas été exclue, qu'il a quand même un soutien, c'est vrai que c'est difficile. Vous voyez des fois des adolescents qui ne savent pas où aller. Mais quand même, il n'y a pas le choix.

(1:03:56 - 1:04:16)

Même les femmes, il y a des maris alcooliques, des médecins, des ingénieurs, vraiment, ce sont

des gens que vous allez rencontrer. Il y a des femmes qui souffrent. Ce que je dis aux parents, aux filles, c'est pénible.

(1:04:17 - 1:04:25)

C'est pénible. Un enfant diabétique, c'est pénible. Mais c'est votre enfant, c'est votre famille.

(1:04:27 - 1:04:56)

Et bien sûr, s'il a des compétences sociales, c'est quelqu'un qui va avoir de l'espoir, avoir un bon avenir, bien travailler, avancer dans la vie. Comme je vous ai dit, toutes les drogues font en sorte d'augmenter la dopamine au niveau de ce qu'on appelle le circuit de récompense. C'est une zone cérébrale qui, une fois stimulée, va continuer à demander de la dopamine pour avoir le même effet.

(1:04:57 - 1:05:21)

Les drogues vont agir par trois mécanismes. Soit ils vont imiter la dopamine et stimuler les récepteurs dopaminergiques, soit ils vont augmenter la sécrétion de dopamine, soit ils vont inhiber la recapture de la dopamine. Dans tous les cas, le résultat, il doit y avoir beaucoup de dopamine.

(1:05:21 - 1:05:40)

C'est leur monde de plaisir. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des plaisirs naturels qu'on peut avoir par des stimulus naturels qui sont l'alimentation. L'alimentation donne du plaisir.

(1:05:43 - 1:05:48)

J'adore manger. Ça donne du plaisir. Et l'alimentation, ça dépend.

(1:05:49 - 1:06:05)

Quel est l'aliment qui donne le plus de plaisir? Le sucre. Le chocolat. Mais pour avoir beaucoup de dopamine, il faut beaucoup de chocolat.

(1:06:06 - 1:06:30)

Mais pour avoir le minimum, oui, le chocolat. En dehors du chocolat, il y a tout ce qui est relation humaine, relation amoureuse, relation sexuelle, relation affectueuse, relation sociale, relation humaine. Rencontrer une amie, prendre un café avec une amie, surtout s'il est positif, sortir avec les amis.

(1:06:31 - 1:06:49)

Pourquoi on conseille de voyager? Voyager, c'est pour changer les visages. Quand vous

voyagez, vous revenez avec une charge de dopamine. Donc rencontrer les amis, sortir avec les amis, aller vers la famille, quelqu'un que vous aimez, parler avec quelqu'un que vous aimez, discuter.

(1:06:49 - 1:07:20)

Donc quand je vous dis, chaque jour, chercher la dose de dopamine que vous avez prise, c'est dans ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez bien mangé, vous avez bien dormi, vous avez rencontré un ami, une amie, pris un café, discuté, pris un jus, sorti ensemble, vous avez fait du sport, vous vous êtes baladé, vous vous êtes reposé, vous avez fait de la méditation, vous avez écouté du courant, d'accord? Tout ça, ça vous donne de la dopamine. La journée, je me suis dépaminé.

(1:07:22 - 1:07:54)

La nuit, quand vous allez dormir, vous faites le récap, qu'est-ce que vous avez fait? Si ça vous manque quelque chose, demain je dois appeler telle personne pour prendre un café, un jus, pour parler, pour discuter. Et il y a bien sûr les plaisirs artificiels. Dans les plaisirs artificiels, il y a les plaisirs qui ne nous donnent pas vraiment de conséquences négatives, comme le jeu, sauf pour moi, jamais je m'imagine, rien que de le voir que je viens de doubler.

(1:07:55 - 1:08:10)

J'ai vraiment le vertige, rien que de voir, et je vois des fois, et ça vous arrive des fois, parce que tu ouvres du TikTok ou du vidéo, des fois je ne veux même pas continuer. Ça, ça donne de la dopamine. Il y a des gens qui cherchent vraiment des sensations comme ça.

(1:08:11 - 1:08:28)

Alors il y a les jeux, ça c'est des conséquences, bien sûr, beaucoup plus familiales, professionnelles et économiques. Et bien sûr, si quelqu'un perd tout son argent, il peut tomber dans les conséquences psychiques, il va déprimer. Et bien sûr, il y a les drogues.

(1:08:29 - 1:10:08)

Un de les deux, ils donnent tous une augmentation de dopamine. Alors comment ça se passe? Les stimulus naturels qui sont bien, notamment la nourriture, les rapports sexuels, affectueux, et les autres plaisirs, le sport, les amis, les voyages, les activités, tout ce que vous faites comme loisirs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont stimuler, ils vont stimuler l'augmentation de la dopamine au niveau de ce qu'on appelle le nucleus accumbens ou bien le circuit de recompense, mais ils vont augmenter la dopamine à un taux qui est normal. Quand on bouge la dopamine, le taux qui est très élevé, mais un taux qui est normal qui va nous donner un bien-être, qui va nous donner une mise en mémoire comme quoi ce produit-là nous a donné un bien-être et qui va nous motiver

à faire quoi? Par exemple, vous êtes sorti avec une amie, vous avez pris un jus, ça vous a fait un bien-être, vous allez le mémoriser au niveau de l'amygdale, comme quoi vous avez eu un bien-être.

(1:10:09 - 1:11:24)

Et au niveau de l'hippocampe, vous allez mémoriser comme quoi c'était avec cette amie que vous avez eu ce bien-être et ça va motiver à faire quoi? À rappeler l'amie une autre fois pour prendre un autre jus. Vous avez pris du chocolat, ça vous a donné un bien-être. Vous avez mémorisé au niveau de l'amygdale le bien-être et vous avez mémorisé au niveau de l'hippocampe, la boîte du chocolat, le magasin où vous avez acheté le chocolat et vous allez être motivé à aller vers le magasin, acheter le chocolat et manger le chocolat.

Et à chaque fois que vous allez passer devant le magasin, vous allez avoir cette sensation de bien-être parce que vous avez mémorisé dans l'hippocampe le lieu et le temps et dans l'amygdale le fait, l'émotion, le bien-être. C'est pour ça qu'on va voir les addicts à chaque fois qu'ils vont passer devant le bar, ils vont avoir le grieving, l'envie et la sensation de ce bien-être qui va le motiver à entrer dans le bar. C'est pour ça qu'on fait l'évitement au début.

(1:11:26 - 1:11:54)

Je vais vous demander de passer et vous allez rentrer sans consommer. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les récepteurs? Pourquoi on dit qu'on est fait pour être addict? Il nous a donné tous les moyens pour être addict. Il nous a donné tous les récepteurs pour être addict.

(1:11:55 - 1:12:11)

Il nous a donné le récepteur nicotinique et les feuilles. Pourquoi? Sur le plan physiologique naturel, c'est qui qui stimule ce récepteur nicotinique? La citricoline. Donc, le récepteur nicotinique pour la citricoline.

(1:12:13 - 1:12:31)

La citricoline, elle a un intérêt. C'est quoi son intérêt? La mémoire. Les récepteurs endocannabinoïdes, c'est pour les endocannabinoïdes, ce sont des hormones.

(1:12:32 - 1:12:38)

Les récepteurs morphiniques, c'est pour les endorphines. Ça, c'est des endorphines naturelles. On en a besoin.

(1:12:40 - 1:12:54)

Donc, c'est des récepteurs qui existent déjà. Le récepteur GABA, c'est pour le GABA, l'acide aminé GABA, qui existe déjà sur le plan physiologique. C'est l'acide aminé, l'inhibiteur le plus

fréquent dans l'organisme.

(1:12:55 - 1:13:21)

Donc, ces récepteurs-là, ils existent déjà. Ils peuvent être stimulés par ces stimulus naturels pour augmenter l'autodopamine, mais à un niveau qui est modéré. Les drogues, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont voler les mêmes récepteurs physiologiques qui existent déjà.

(1:13:23 - 1:13:38)

Le récepteur nicotinique, il va être utilisé par le tabac. Le récepteur cannabinoïde, il va être utilisé par le cannabis. Le récepteur GABA, il va être utilisé par l'alcool.

(1:13:38 - 1:14:17)

Les récepteurs endorphines, ils vont être utilisés par l'héroïne. Ces substances-là, ils vont stimuler ces récepteurs-là et regardez comment ils vont augmenter la dopamine. Donc, on a dit, soit par stimulation, augmentation de taux de dopamine libéré, soit ils vont agir par inhibition de la recapture.

Le cannabis, il va agir aux deux niveaux. La cocaïne, il va inhiber la recapture. L'ecstasy, l'amphétamine, ils vont inhiber la recapture de sorte que le résultat est l'augmentation de la dopamine.

(1:14:17 - 1:15:01)

Mais regardez le taux de dopamine, il est beaucoup plus élevé que l'augmentation qui est due au stimulus naturel. Alors, le bien-être ressenti par ces substances-là, est-ce qu'il va être le même bien-être que par le chocolat? Ça va être un bien-être extrême. Alors, qu'est-ce que vous allez mémoriser? Que l'alcool, la cocaïne vous a donné un bien-être qui est supérieur au bien-être que vous avez eu avec le chocolat, bien avec Mamy, ou bien juste que ça vous a donné un bien-être qui est extrême.

(1:15:01 - 1:15:37)

Ça, vous allez le mémoriser au niveau de la migdale, au niveau de l'époquant, vous allez mémoriser avec qui vous avez consommé la cocaïne ou vous avez consommé la cocaïne. Bien sûr, ça va vous motiver à faire quoi? Ça va motiver les addicts à faire quoi? À reconsommer les substances et à laisser tomber le stimulus naturel. Parce qu'on a dit qu'on dépend d'autres moyens de plaisir.

(1:15:38 - 1:15:53)

Une fois qu'ils tombent dans l'addiction, le seul moyen pour avoir du plaisir chez ces patients,

c'est la drogue. Ils oublient les autres moyens. Et quand vous allez leur dire qu'il faut faire du sport, ça ne donne pas le même effet.

(1:15:54 - 1:16:02)

Oui, ça ne donne pas le même effet. Mais qu'est-ce qu'on cherche? Un plaisir normal comme tout le monde. On ne cherche pas l'extase.

(1:16:03 - 1:16:24)

L'extase, on ne cherche pas la joie, on ne cherche pas l'euphorie. Et ce qu'on cherche, c'est un minimum de plaisir, un plaisir modéré sans conséquences négatives. Alors que vous, vous avez, c'est vrai, l'extase, l'euphorie, la joie, mais avec des conséquences négatives.

(1:16:24 - 1:17:00)

D'accord? Voilà comment ça fonctionne. Quand vous expliquez ça aux patients, qu'est-ce qu'ils sont sur le plan biologique? Qu'il a été quoi? Qu'il a été quoi par la drogue? Qu'il a été piégé par la drogue? La drogue n'a fait qu'utiliser ses récepteurs physiologiques pour augmenter la dopamine. Donc il est tombé dans le piège de la drogue.

(1:17:03 - 1:17:32)

Est-ce que c'est bien clair, la théorie biologique de la drogue? Donc vous, les addicts, ils mémorisent dans l'amygdale tout ce qui est valeur émotionnelle. Ça leur a donné de l'extase, de l'euphorie, de la joie, de l'hyperactivité, de la désinhibition. Et ils ont mémorisé aussi que toute sa sensation, c'est en rapport avec ce lieu-là et avec cette personne-là, avec ce temps-là.

(1:17:34 - 1:17:59)

C'est pour ça que les gens, quand ils sortent par exemple au café, dès qu'il est assis au café, il a cette nostalgie et il lit toujours le café, la tasse du café avec la cigarette. Quand il est au balcon de sa maison, c'est toujours la tasse du café, elle est liée avec le plaisir. Dans sa tête, elle a mémorisé ces deux sensations avec le lieu.

(1:18:02 - 1:18:12)

Alors on dit que les drogues, elles viennent se greffer sur les voies du plaisir. C'est un véritable leurre pharmacologique. C'est quoi le mot? Les récepteurs.

(1:18:14 - 1:19:01)

D'accord? Par rapport aux addictions comportementales, ça augmente aussi la dopamine, ça augmente aussi cette sensation de plaisir. Et les sujets commencent à rechercher des plaisirs pour éviter les souffrances. Et chez ces personnes-là qui sont addictes au comportement, on

travaille beaucoup plus la gestion des émotions positives et la gestion des émotions négatives.

Parce que des fois, même l'émotion positive peut amener à l'addiction. Surtout chez les addictions comportementales, même quand il gagne, quand il gagne beaucoup d'argent, il ne va pas arrêter. C'est une émotion, il est heureux, il est content, mais il va continuer, même s'il a une émotion positive.

(1:19:02 - 1:19:54)

Alors on va venir vers chaque produit, donc on va voir les différents produits. Il y a les produits psycholeptiques ou bien dépresseurs du système nerveux central, c'est des produits qui vont calmer. Les personnes addictes cherchent l'apaisement en consommant ces produits.

C'est le cas, par exemple, des anxiolytiques, les OPC, c'est l'héroïne et les barbituriques. Il y a des personnes qui vont chercher à être stimulées et vont vers les stimulants ou bien les psychoanalytiques, c'est les amphetamines, la cocaïne, la caféine, la nicotine. Il y a des produits qui vont perturber, perturbateurs du système nerveux central, c'est le cas du cannabis, les dérivés hallucinogènes et l'alcool et l'alcool scientifique ou bien les solvants.

(1:19:56 - 1:20:30)

Le cannabis, voilà la plante du cannabis, vous l'avez déjà vue, elle pousse dans le jardin, même en Marrakech, vous pouvez la trouver dans des maisons, dans certains jardins, elle peut pousser. Alors là, avec la légalisation, on va voir vraiment, les champs peuvent rester les mêmes, seulement ils vont être respectés et ils vont être légalisés. Mais si on la légalise, c'est dans une vertu thérapeutique.

(1:20:31 - 1:20:56)

Alors le type de préparation, vous voyez la feuille, vous voyez la résine. La résine, c'est ce qui est facile à vendre, facile pour les dealers, facile aussi à consommer, et la plupart, quand ils consomment, ils consomment la résine. Donc la plante elle-même ou bien l'huile, elle n'est pas vraiment très utilisée.

(1:20:57 - 1:21:53)

Mais on peut les utiliser en les mélangeant avec les autres drogues, par exemple. Là, vous voyez, en fonction des pays, comme on dit, le Maroc fait partie des pays qui ont la bonne qualité du cannabis. La bonne qualité, c'est en rapport surtout avec la teneur du produit qui est responsable de l'addiction.

Quel est le produit qui est responsable de l'addiction dans le tabac? La nicotine. Le tabac, vous savez qu'il y a 4000 constituants. Même pour le cannabis, il y a 3000 ou 4000 constituants.

Mais celui qui est responsable de la dépendance du tabac, c'est la nicotine. Dans le cannabis, celui qui est responsable de la consommation, c'est le tetrahydrocannabinol. C'est le 9-tetrahydrocannabinol.

(1:21:54 - 1:22:49)

C'est un produit qui donne l'addiction au cannabis. Les autres produits, ce sont des produits qui peuvent être toxiques. Ce sont des produits qui vont donner des effets somatiques comme pour le tabac.

Et pour traiter le tabac, on fait bien sûr sortir la nicotine. On fait des patches nicotiques pour éviter les complications de la santé. On garde juste le produit qui donne la nicotine et on va diminuer progressivement.

Aussi, il y a des produits du cannabinoïde qui vont retirer que le 9-tetrahydrocannabinol qui donne la dépendance pour traiter l'addiction au cannabis. Si on parle du cannabis, on voit que quand même, sa prévalence est élevée si on la compare à la cocaïne ou bien à l'héroïne. C'est deux fois.

(1:22:50 - 1:23:18)

Comme je vous ai dit, pour le tabac, il y a 400 constituants dont le seul qui donne l'effet psychotrope ou bien l'effet de dépendance, c'est le delta-9-tetrahydrocannabinol. L'élimination est faite par voie fécale et rénale. L'intérêt du dosage pour les gens surtout qu'on va suivre s'ils consomment ou pas.

(1:23:19 - 1:23:36)

La demi-vie va rester dans le sang huit jours. Le mode le plus utilisé, c'est fumer, mais il y en a qui vont le mâcher. Là, c'est un tableau récapitulatif pour le dépistage.

(1:23:36 - 1:24:17)

Le dépistage le plus fréquent, c'est au niveau des héroïnes. On va le chercher au niveau des héroïnes. Les autres dépistages, ils ont soit peu d'intérêt, soit très coûteux, soit au niveau de la salive, la sueur.

Comme vous voyez, au niveau des cheveux, on peut le détecter de façon infinie. Il va rester longtemps, mais ça reste quelque chose de très coûteux qu'on ne peut pas faire régulièrement. Les urines, on peut le faire.

S'il y a des consommations occasionnelles, on peut le trouver jusqu'à sept jours. S'il y a une consommation régulière, on peut le trouver jusqu'à 21 jours. Ça, on peut le faire.

(1:24:17 - 1:26:11)

En fait, quand on thérapie avec le patient, on ne va pas surveiller. On est dans une relation de confiance, mais on le fait des fois en accord avec le patient. Je vais vous faire un dosage.

On le fait en cas d'hospitalisation quand on donne des patients, des fois aux patients, des permissions de sortie. À l'arrêt d'hospitalisation, on leur fait le dosage. Bien sûr, pourquoi on va consommer? Comme je vous ai dit, il y a des effets positifs à la consommation.

C'est l'euphorie, la convivialité, la modification de l'état de conscience. Les sujets vont oublier. Des fois, ils vont être dans un état second.

Ils vont être, comme ils disent, force silk, soulager le stress. Ils vont être relaxés, apaisés. Ils vont chercher le sommeil.

Il y a des gens qui consomment tout la nuit. Ils ne dorment pas s'ils consomment deux, trois joints à la nuit, par exemple. Donc ça, c'est très important.

Il faut le reconnaître. Je comprends, je sais, mais on va voir comment remplacer ce moyen par un autre moyen. Bien sûr, il y a des gens qui ignorent les problèmes somatiques du cannabis.

La majorité des gens, c'est vrai, ils vont, on mélange normalement quand on le fume, on le mélange avec le tabac. Donc l'effet du tabac s'ajoute. Les cancers, les rhinites, les branchites, les irritations, les inflammations, ils vont s'aggraver.

Mais le cannabis à lui seul, il peut donner aussi ces effets-là. Alors ça, c'est pour les détecter. Des fois, les larmes, les yeux qui sont rouges, les médias, la sécheresse buccale, la faible dépression respiratoire au début.

Donc tout ça, c'est des effets secondaires physiques qu'on peut voir avec le cannabis. Et il y a les effets qui font peur aux patients. C'est beaucoup plus les effets neuropsychiques.

(1:26:13 - 1:27:18)

Ça peut être un état d'angoisse aiguë qui peut aller jusqu'aux attaques de panique. Ça arrive. Et des fois, c'est un symptôme qui va dissuader les patients à recommencer à consommer.

Ça peut être de l'agitation, de l'irritabilité, des hallucinations. Ça, c'est l'effet, début d'effet parano, la méfiance et bien sûr les réflexes qui vont diminuer, les coordinations motrices qui vont diminuer et l'atteinte de la mémoire, la concentration et l'attention. Les étudiants, il y a des étudiants, beaucoup d'étudiants, ils ont ces fausses messages comme quoi ça donne de l'éveil, ça les éveille.

C'est vrai au début. Ils sont là, ils ont l'impression qu'ils suivent bien, qu'ils mémorisent bien, qu'ils

font beaucoup plus attention. Leur concentration est élevée.

Mais quand ils rentrent chez eux, après quelques jours, tout est effacé. Donc ça, c'est un problème. Alors après, là c'est les problèmes neuropsychiatriques.

(1:27:19 - 1:28:00)

L'intoxication cannabique ou bien l'ivresse cannabique qui va survenir deux heures après la prise, c'est des effets qui vont durer trois à huit heures avec des perturbations cognitives, l'attention, la conscience, la mémoire qui va durer jusqu'à 24 heures. Alors ça va se manifester par de l'euphorie, des modifications sensorielles, ça peut être des hallucinations auditives, visuelles, et bien sûr c'est en fonction de la dose. Ça peut être juste des illusions, ça peut être un sentiment de ralentissement du temps.

(1:28:00 - 1:28:43)

Et ça c'est des choses qui sont recherchées par les patients, des problèmes cognitifs, problèmes de la coordination, des atteintes carrément physiques, des crampes, des tremblements, mal à respirer, des palpitations, des vomissements, des angoisses, des confusions, de la sueur qui est froide. Et ça c'est des symptômes qui peuvent apparaître même pendant le sevrage. Ça c'est des symptômes aigus, des signes aigus dus à l'intoxication aiguë qui va survenir deux heures ou qui va persister 24 à 48 heures par la suite.

(1:28:44 - 1:29:04)

Il y a aussi ce qu'on appelle les complications chroniques, ce qu'on appelle le syndrome amotivationnel. Ça c'est un trouble qu'on va trouver avec toutes les consommations, mais surtout avec le cannabis. Vous allez voir que ce sont des symptômes qui vont nous prêter confusion avec un début de schizophrénie, avec les symptômes déficitaires de la schizophrénie.

(1:29:05 - 1:30:10)

C'est des déficits de l'activité des patients qui vont devenir des sujets, des adolescents, des étudiants qui vont devenir ralentis avec une asthémie intellectuelle. Vous allez voir des fois arriver à la deuxième année, troisième année de la faculté, deuxième et troisième années de médecine, il va y avoir une asthémie intellectuelle, asthémie physique, il n'arrive plus à suivre les cours, n'arrive plus à apprendre, n'arrive plus à voir ses modules, à réussir ses modules. Au début, par exemple, quand il y a les modules camines, après deux, un module difficilement, un flou de la pensée, difficulté de concentration de la mémoire et bien sûr de l'isolement.

Il va s'isoler de la famille, il va devenir déficitaire. Jusqu'à des fois avoir ce qu'on appelle un pragmatisme, c'est carrément déficitaire. Bien sûr, il y a une relation entre la dépression et l'anxiété et le cannabis.

(1:30:11 - 1:30:30)

Il peut jouer un rôle dépressogène, modeste des fois. Des fois, il peut jouer le rôle de dépression suite aux conséquences. S'il ne veut plus réussir, par exemple, sa vie, s'il y a des conflits avec la famille, ça peut se compliquer de dépression et il peut avoir des troubles anxieux.

(1:30:31 - 1:31:15)

Le problème le plus fréquent avec le cannabis, c'est les attaques de panique. Ça arrive souvent chez les adolescents, surtout à la première prise. Sinon, c'est des sensations de dépersonnalisation et de déréalisation.

C'est la sensation d'étrangeté de son corps. Le sujet a l'impression qu'il est sorti de son corps et il est spectateur de son corps dans le milieu extérieur, ou bien un sentiment de déréalisation du monde extérieur. C'est la sensation, par exemple, que ce n'est pas un vertige, mais même si les immeubles sont en train de bouger, les voitures en stationnement sont en train de bouger.

(1:31:15 - 1:31:58)

C'est bizarre, la sensation de bizarrerie du monde extérieur. Ça peut aller jusqu'à des troubles psychotiques carrément. C'est ce qu'on appelait avant les bouffées délirantes aiguës, qu'on appelle maintenant les accès psychotiques aiguës dont on a parlé tout à l'heure.

Le plus souvent, c'est des accès psychotiques aiguës d'allure maniaque où il y a beaucoup plus de l'euphorie, de l'agitation, de la joie. Ils sont de bons pronostics par rapport aux autres accès psychotiques aiguës, s'il y a beaucoup plus d'éléments dissociatifs. En général, il y a une résolution rapide et efficace avec les traitements neurologiques.

(1:31:59 - 1:32:16)

Si ça ne s'améliore pas rapidement avec le neurologique, ça veut dire que c'est de mauvais pronostics. Le sujet est à risque d'évoluer vers un autre problème. Ce qu'il y a beaucoup plus avant d'arriver à l'accès psychotique aiguë, c'est ce qu'on a appelé les sensations paranoïaques.

(1:32:18 - 1:32:36)

C'est le sentiment de persécution ou bien l'effet parano. Ça, on le pose aux patients. Le syndrome de sevrage par rapport au cannabis, c'est très important, il faut le connaître.

(1:32:36 - 1:33:45)

Le syndrome de sevrage peut commencer après 24 heures d'abstinence, le maximum de 2 à 4 jours, et il diminue après 7 heures. Et ça, il faut le retenir pour encourager le patient. Il suffit qu'il résiste au bout d'une semaine, dix jours, tout va rentrer dans l'ordre parce que les signes de

sevrage les ont et les appréhendent et les redoutent.

Les gens qui consomment le cannabis, pourquoi ils ne vont pas arrêter deux jours à consommer? Parce qu'ils ne voudront pas tomber dans le syndrome de sevrage qui est fait par ces signes-là. Ils ne voudront pas être dans un état où ils vont avoir de la colère, de l'agressivité, de l'anxiété, de l'irritabilité, de l'angoisse, de l'insomnie, des rêves, des cauchemars, ou bien des frissons, ou bien des douleurs abdominales minimes. Pas autant que les douleurs causées par l'héroïne.

(1:33:45 - 1:34:05)

Ils ne voudront pas avoir des tremblements, des sueurs, la timidité, et surtout, ils ne voudront pas être tristes. Donc, il faut les encourager comme quoi ces signes vont disparaître au bout de dix jours au maximum. Après, on va travailler sur le grieving, sur les dépendances psychiques.

(1:34:05 - 1:34:14)

Et si jamais il vient après trois jours d'abstinence, il faut l'encourager. Trois jours, c'est un exploit. Bravo, vous avez pu arrêter trois jours.

(1:34:15 - 1:34:40)

S'il vient après deux semaines, deux semaines. Vous avez dépassé le cap, le risque. Bravo.

Donc, il faut ce qu'on appelle encourager l'efficacité personnelle, parce que là, c'est un exploit. Quelqu'un qui arrête. Imaginez, là, vous les voyez, les patients tabagiques, le ramadan, qu'est-ce qu'ils font ? La cigarette.

(1:34:41 - 1:35:00)

Ou bien, il prend le café, il va prendre la cigarette. Donc, il peut, une journée, il peut rester dans le balcon à prendre le café, la cigarette, ou après une demi-heure, il arrête. Donc ça, quand on dit un exploit, c'est vrai que c'est un exploit.

(1:35:01 - 1:35:09)

Parce que lui, il le sent, le patient le sent, ce qu'il a fait comme effort. C'est un grand effort. Alors, on vient au deuxième.

(1:35:09 - 1:35:57)

Après le cannabis, j'ai fait comme ça par ordre de fréquence, de gravité, ou bien des gens que vous allez voir, les benzodiazépines, ils sont aussi fréquents, parce que parfois, cette dépendance est causée par des prescripteurs, dépendance qui est causée par les médecins. Alors, bien sûr, il y a des sujets à risque, et l'effet recherché par ces substances, c'est la sédation, la diminution de l'anxiété, la relaxation, améliorer le sommeil, mais ça donne aussi

d'autres effets qui sont l'incoordination motrice, le ralentissement, les troubles de mémoire, les troubles du caractère. Ça donne aussi des intoxications aiguës.

(1:35:57 - 1:36:45)

Vous le savez, il y a des gens qui vont se suicider par les anxiolytiques, parce que ça leur donne du courage à faire un acte beaucoup plus agressif. Il y a des gens qui, avant de se suicider, par exemple, par pendaison ou par un moyen très fort, ils vont consommer du benzodiazépine ou ils vont consommer de l'alcool. Ça les désinhibe et ça leur donne du courage pour passer à un moyen plus fort.

À part ça, ça peut donner aussi des problèmes graves qui est le problème des crises épileptiques ou convulsives à forte dose. Les crises convulsives ou épileptiques, on peut les avoir à forte dose comme on peut les avoir au sevrage brutal. Donc, les deux à éviter.

(1:36:46 - 1:37:00)

Ça peut donner des troubles cardiovasculaires, ça peut donner des dépressions respiratoires et coma. D'ailleurs, ils sont contre-indiqués chez les patients qui ont des problèmes respiratoires. Donc, il faut faire attention aux patients à risque.

(1:37:01 - 1:37:48)

Un dépressif suicidaire, on ne lui donne pas les anxiolytiques à utiliser lui-même. Bien sûr, on va le confier à quelqu'un d'autre qui va lui donner les doses que vous avez prescrites pour respecter les doses. Par rapport au syndrome de sevrage, il survient 12 heures à 3 jours après l'arrêt.

Des fois, vous voyez des patients dès le réveil, ils vont consommer à midi, vers midi, ils ne peuvent pas s'empêcher de consommer. Donc, des troubles neuro-végétatifs, surtout ce qui a craint, c'est les problèmes convulsifs. Sinon, ça peut donner des autres problèmes somatiques comme les autres produits.

(1:37:49 - 1:38:29)

Les produits volatiles et les solvants organiques, ce n'est pas uniquement l'apanage des adolescents ou bien des sujets sans domicile fixe, des sujets marginalisés, mais il y a des étudiants aussi qui prennent ça. Moi, je me rappelle l'histoire d'un étudiant quand il est venu chez moi, il était au baccalauréat, mais il avait commencé à consommer à un âge très précoce et c'est un garçon qui avait double vie. C'est un garçon qui était brillant.

(1:38:29 - 1:38:58)

Il avait des 18-19 ans en maths, en sciences, en physique. Il était bien propre, mais il s'habillait toujours avec des chemises longues. Personne ne soupçonnait que le garçon consommait.

Il était calme à la maison, mais il vivait une deuxième vie ailleurs et surtout la nuit. C'est quelqu'un qui travaille bien. Les parents n'avaient pas de soucis avec ce garçon, ils ne pouvaient pas le soupçonner.

(1:38:58 - 1:39:38)

Il travaillait bien, toujours de bonne note et il était vraiment très apprécié à l'école. Ils lui ont acheté une moto et il rentrait tard la nuit. Puisqu'il travaillait bien à chaque fois, bien sûr, il disait à ses parents qu'il travaillait avec des élèves, avec ses amis, c'est pour ça qu'il rentrait tard la nuit.

Alors que lui, la nuit, il consommait et il avait une deuxième vie, du cannabis, de l'alcool synthétique et de l'alcool. Et il était vraiment un bagarreur la nuit. Il se promenait avec sa moto et avec un couteau parce qu'il était dans des milieux à risque avec les gens qu'il consommait et il avait ça pour se défendre.

(1:39:39 - 1:39:53)

Et quand il me racontait la nuit, il m'a dit « Marrakech, la nuit, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez. » Et bien sûr, à un moment, de lui-même, il en avait marre de cette vie, de vivre une double vie.

(1:39:54 - 1:40:27)

Et comment il a décidé? Il est allé chez ses parents et il leur a tout révélé. Comme quoi, je crois qu'il avait commencé à 14 ans, 15 ans, à consommer et il leur a dit « Je suis addict à l'alcool, le cannabis, la cocaïne, l'héroïne, tout. J'ai tout consommé.

» Et là, bien sûr, il a soulevé les manches et il avait des automotivations tout simplement. Et ses parents n'ont jamais posé la question pourquoi il ne voulait pas aller avec eux à la plage, à la piscine. Il aimait toujours garder des chemises.

(1:40:28 - 1:40:45)

Et ils l'ont amené à la consultation. Les parents, vraiment, se sont culpabilisés. Comment ils n'ont pas fait attention à cet enfant? A la maison, il était calme.

A l'école, il était calme. Il travaillait très bien, mais il menait une double vie. D'accord? Donc, c'est pour vous dire que les drogues peuvent être la panache de tout le monde.

(1:40:46 - 1:41:00)

Les solvants, bien sûr, les gens recherchaient parmi les effets qui peuvent être négatifs, c'est cette ivresse. Mais ces personnes-là, ils recherchaient cette ivresse. Ils cherchaient l'ivresse.

(1:41:02 - 1:41:15)

Donc, ils cherchaient ça pour ne plus penser à leur existence. Ça donne des vertiges, de l'euphorie, des hallucinations. Ça entraîne des altérations de l'état général parce que ce sont des gens qui vont se négliger.

(1:41:15 - 1:41:21)

Ils ne vont pas manger bien. Ils ne vont pas y avoir une bonne hygiène. Ils ne vont pas bien dormir.

(1:41:22 - 1:41:36)

Donc, ça entraîne des altérations et, bien sûr, ça entraîne des problèmes de jugement. Il va y avoir des problèmes de jugement. Ils vont se bagarrer.

Ils vont être des voleurs. Ils vont faire des va-et-vient au commissariat. Ils vont être incarcérés à plusieurs reprises.

(1:41:36 - 1:41:51)

Donc, ces produits-là entraînent beaucoup plus de la désocialisation. Après, il y a les opiacés. Les opiacés, c'est tout ce qui est morphine, héroïne, codéine, ontalgique.

(1:41:53 - 1:42:39)

Il y a des produits qui se vendent dans la pharmacie. Là, maintenant, on commence à être beaucoup plus rigoureux par rapport à la prescription. Par exemple, le codoliprane, ça contient de la codéine et il y a des gens qui vont se droguer avec ça, qui vont l'utiliser pour se droguer.

Alors, ça s'est extrait d'une fleur, d'une plante. C'est quoi le problème du cannabis ? C'est qu'une plante, c'est vrai, mais tout provient d'une plante. Aussi, la morphine et, bien sûr, comme je vous l'ai dit, l'héroïne, elle est un dérivé semi-synthétique de la morphine qui est fabriquée, bien sûr, dans des laboratoires clandestins.

(1:42:40 - 1:43:02)

Et quand on peut la mélanger avec de l'aspirine et du bicarbonate, ça donne un mélange qui est beaucoup plus puissant avec un changement de couleur. Elle est utilisée. Normalement, l'héroïne, elle est injectée, mais on peut l'utiliser aussi sniffée, on peut l'utiliser aussi fumée.

(1:43:03 - 1:43:18)

La cocaïne, elle est sniffée, mais aussi injectée et fumée. Le mélange, les moyens d'utilisation, les addicts sont experts dans ça. Et là, vous avez entendu parler de la poufada.

(1:43:20 - 1:43:51)

Ça, c'est des mélanges, des choses découvertes par les addicts eux-mêmes. Ce qui est recherché par les héroïnomanes, c'est cet effet brutal, intense au début de l'euphorie. Après, elle est suivie d'un état de bien-être, d'un apaisement, d'un calme, et les gens sont ralentis, ils peuvent même dormir.

(1:43:52 - 1:44:42)

Et bien sûr, physiquement, vous le voyez dans les films, c'est associé à un réchauffement cutané. Ça peut donner un prurite, ça peut donner de la tachycardie, de l'hyperglycémie, et c'est ça qui peut entraîner, en cas d'overdose, la mort. Sur le plan psychique, ça entraîne des dépressions, ça entraîne même des troubles psychotiques, donc ce n'est pas quelque chose de spécifique.

Ça peut entraîner la mort par overdose. Parmi les complications infectieuses qui sont caractéristiques de l'héroïne, c'est les infections par embolie, par endocardite. Surtout, elle est due au produit qu'on échange entre les consommateurs parce qu'il est utilisé le plus souvent par voie injectable.

(1:44:42 - 1:45:15)

Et bien sûr, il y a des complications sociales, des homicides, des vols, des agressions. Alors, le syndrome de sevrage, comme je vous ai dit, il est caractéristique dans l'héroïne par rapport aux autres, surtout par le larmoiement, le baillement, les frissons, les sueurs qui sont très importants et la médiase bilatérale. Ça, vous pouvez détecter, c'est le sujet en sevrage et par les douleurs.

(1:45:15 - 1:45:37)

Donc, les sujets qui redoutent le sevrage et qui ne veulent pas arrêter, c'est surtout à cause des douleurs abdominales, lombaires, thoraciques qui sont vraiment très intenses. Et vous allez voir dans le traitement, on va donner des antalgiques, des antispasmodiques à forte dose pour essayer de calmer. Alors, je termine presque.

(1:45:38 - 1:46:58)

Donc, on vient à la cocaïne qui est extraite aussi d'une plante et bien sûr qui entraîne des complications psychiatriques aussi, la même chose que les autres produits, donc des complications non spécifiques, des troubles de l'humeur et peuvent aller aussi jusqu'aux troubles psychotiques par des hallucinations. L'overdose qui entraîne des labors, le décès, soit par un état d'épilepsie, de mal épileptique ou bien par un arrêt respiratoire. Une complication particulière à la cocaïne par rapport aux autres, c'est les multiples infections ORL, les ulcérations et les perforations de la cloison nasale.

Et ça, vous savez pourquoi ? Parce qu'elle est beaucoup plus sniffée et c'est ça qui donne

beaucoup plus de perforations de la cloison nasale. Donc, ces sujets-là, ils auront besoin par la suite d'une prise en charge ORL à part la prise en charge psychiatrique. Un autre produit, c'est les LSD, c'est des produits hallucinogènes puissants.

(1:46:58 - 1:47:45)

C'est parmi les plus puissants des hallucinogènes et bien sûr, ils entraînent aussi des troubles beaucoup plus cognitifs, des troubles beaucoup plus de comportement avec des passages à l'acte surtout hétéro-agressifs parce qu'ils ont des hallucinations auditives et visuelles et surtout de la persécution avec des persécuteurs désignés. Donc, il peut y avoir des passages à l'acte. Ils entraînent beaucoup plus de la dépendance psychique.

Par rapport aux dépendances, l'héroïne entraîne beaucoup plus de la dépendance physique. La cocaïne entraîne beaucoup plus de la dépendance psychique que physique. L'ecstasy, ça vous le connaissez, c'est un produit beaucoup plus utilisé par les étudiants pendant les fêtes.

(1:47:46 - 1:48:09)

En général, les étudiants, les adolescents l'utilisent le week-end, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours pendant les fêtes, mais il y en a qui vont tomber dans les addictions et l'utiliser chaque jour. Ça donne de l'excitation. Ce qu'ils recherchent chez ces étudiants, c'est éliminer cette fatigue et être stimulés.

(1:48:10 - 1:48:24)

Mais il faut savoir que ça donne aussi des complications psychiatriques et ça peut aussi entraîner la mort par des troubles cardiaques. La conduite à tenir, on va la laisser pour la prochaine fois quand on va voir les psychothérapies.